

Geriatria e Demências

Imagina a seguinte situação: Dona Maria, 82 anos, viúva, mora sozinha. Chega ao consultório trazida pela filha, que relata algo preocupante - a mãe está perdendo autonomia. Antes fazia tudo, agora não consegue mais. Teve quedas recentes, não procurou atendimento. Queixa-se de esquecimentos, dificuldade para gerenciar as finanças e perda de peso não intencional. Usa cinco medicações diferentes para hipertensão, diabetes e insônia. No exame físico, apresenta marcha lenta, instabilidade postural, IMC baixo e humor deprimido. Deixou de participar dos grupos de convivência e passa a maior parte do tempo em casa. Os exames laboratoriais? Normais.

Como avaliar e conduzir esse tipo de caso? É exatamente isso que vamos desvendar agora, porque quando falamos do **paciente geriátrico**, precisamos enxergar o conjunto - não é só um sintoma isolado, são múltiplas nuances que se entrelaçam e exigem uma abordagem completa para proporcionar qualidade de vida e longevidade.

Conceitos Fundamentais: Envelhecimento não é Adoecimento

Primeiramente, grave isso: **envelhecimento é diferente de adoecimento**. São pontos totalmente opostos. Quando falamos de envelhecimento, estamos nos referindo às alterações fisiológicas da idade, a chamada **senescência**. O indivíduo idoso vai ter algumas regulações diferentes no sistema cardiovascular, o trato gastrointestinal fica diferente, a pele se modifica, o trato geniturinário passa por mudanças. A parte cognitiva e neurológica também apresenta alterações, mas tudo isso faz parte do processo normal.

Agora, a **senilidade** é outra história. Quando o paciente idoso adoece, precisamos intervir e tratar. Não podemos aceitar passivamente sintomas sob o argumento de que "é normal da idade". Essa é uma **pegadinha clássica de prova** - nunca normalize patologias apenas porque o paciente é idoso.

Avaliação Geriátrica Ampla: Os Pilares

Quando abordamos o paciente geriátrico de forma completa, avaliamos cinco domínios principais: **cognição, humor, funcionalidade, mobilidade e sensibilidade** (principalmente audição e visão).

Cognição: Mini Exame do Estado Mental (MEEM)

O **MEEM** é uma ferramenta extremamente significativa para rastreio cognitivo. É um teste rápido, fácil de aplicar e pode ser usado em indivíduos com algum grau de alfabetização. Para analfabetos, existem adaptações específicas.

Comentário crítico importante: o MEEM é um teste de rastreio, não fecha diagnóstico. Se o paciente pontua baixo, isso sinaliza que provavelmente existe algo por trás, mas você precisa investigar mais a fundo com testes mais sensíveis e específicos.

O que o MEEM avalia?

- **Orientação** em tempo e espaço (5 pontos cada)
- **Registro** ou memória imediata (repetir 3 palavras logo após ouvi-las - 3 pontos)
- **Atenção e cálculo** (subtrair 7 de 7 sucessivamente ou soletrar "MUNDO" de trás para frente - 5 pontos)
- **Evocação** ou memória recente (lembrar das 3 palavras ditas anteriormente - 3 pontos)
- **Linguagem** (nomear objetos, repetir frase, seguir comando de 3 etapas, ler, escrever - vários pontos)

- **Habilidade visuoespacial** (copiar pentágonos sobrepostos - 1 ponto)

Pontos de corte por escolaridade:

- Analfabetos: 19 pontos
- 1-3 anos de estudo: 23 pontos
- 4-7 anos de estudo: 24 pontos
- Mais de 7 anos de estudo: 28 pontos

Pegadinha de prova: algumas questões cobram esses pontos de corte. Atenção especial quando a questão fornecer a escolaridade do paciente e a pontuação no MEEM - você precisa saber se está adequado ou não.

Existe também o **MoCA** (Montreal Cognitive Assessment), que é um teste mais elaborado e sensível que o MEEM, avaliando mais domínios cognitivos. Geralmente é preferível para pacientes alfabetizados com nível de escolaridade mais elevado.

Humor: Escala de Depressão Geriátrica

Olha que interessante a questão da UNIFESP 2020 que ilustra isso perfeitamente: Paciente de 82 anos com queixa de esquecimento e mal-estar. Deixou de frequentar o clube dos idosos, prefere ficar em casa, perdeu prazer nas atividades habituais, nega tristeza mas tem bom apetite. Refere irritação porque perde objetos, não acorda descansada pela manhã, aparenta estar distraída durante toda a consulta. Qual instrumento melhor se aplica?

A resposta é a **Escala de Depressão Geriátrica (GDS)**. Por quê? Porque no fundo, toda essa sintomatologia tem como base provável uma alteração de humor. A paciente não está mais frequentando lugares, está ficando irritada, não acorda descansada (provavelmente ansiosa, dorme mal), fica distraída. Tudo aponta para depressão, mesmo ela negando tristeza explicitamente - idosos frequentemente manifestam depressão de forma atípica.

Pontuação da GDS:

- 0-5: Normal
- 6-10: Depressão leve a moderada
- 11-15: Depressão grave

A escala inclui perguntas como: está satisfeito com a vida? Deixou de fazer atividades que gostava? Acha que a vida está vazia? Sente-se aborrecido com frequência? Sente-se de bom humor? Tem medo que algo ruim aconteça? Sente-se feliz? Sente-se desamparado?

Funcionalidade: Escalas de Katz e Lawton

É importantíssimo avaliar se o idoso está conseguindo realizar suas atividades do dia a dia. Para isso, usamos duas escalas complementares:

Escala de Katz - Atividades Básicas de Vida Diária (ABVDs): Avalia capacidades fundamentais:

- Tomar banho sozinho ou precisa de ajuda?
- Consegue vestir roupas sem auxílio?
- Usa o banheiro de forma independente?
- **Transferência:** consegue levantar-se da cama/cadeira sem ajuda?
- **Continência:** controle urinário e fecal preservado?
- Consegue alimentar-se sem ajuda?

Pegadinha de prova: a escala de Katz é famosa e algumas provas cobram especificamente essas funcionalidades. Fique atento aos itens avaliados.

Escala de Lawton - Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVDs): Avalia atividades mais complexas:

- Consegue ir à rua sozinho?
- Consegue ir ao banco, mexer com dinheiro?
- Consegue fazer compras no mercado?

- Consegue fazer uma ligação telefônica?
- Consegue preparar refeições?
- Consegue fazer trabalhos domésticos?
- Consegue tomar medicações corretamente?

Essas atividades instrumentais são mais elaboradas e avaliam se o paciente mantém funcionalidade para viver de forma independente.

Mobilidade: Timed Up and Go

É um teste simples mas muito útil. O paciente, que está sentado, deve levantar-se da cadeira sem ajuda, caminhar 3 metros, virar e retornar ao ponto inicial. Você cronometra todo esse trajeto.

Interpretação: se levar mais de 20 segundos, aquele paciente tem risco aumentado de quedas. Simples assim.

Sensibilidade: Visão e Audição

Avaliar se o paciente usa óculos, se está enxergando bem, se usa aparelho auditivo, se a audição está preservada. Déficits sensoriais impactam diretamente a qualidade de vida e podem até simular ou agravar quadros cognitivos.

As Grandes Síndromes Geriátricas: Os 7 I's

Para fazer uma busca ativa adequada no paciente idoso, precisamos conhecer os chamados **7 I's da geriatria**. Muitas vezes o próprio idoso ou a família não trazem essas queixas porque acham que "é normal do envelhecimento". Por isso a busca ativa é fundamental.

1. **Incapacidade cognitiva** (demências)
2. **Instabilidade postural** (aumenta risco de quedas, fraturas, acamamento e mortalidade)
3. **Imobilidade**

4. **Iatrogenia** (especialmente por polifarmácia - idosos usam múltiplas medicações para hipertensão, diabetes, dislipidemia, hipotireoidismo, transtornos de humor, e muitas vezes essas medicações estão mal indicadas, causam efeitos colaterais ou interações medicamentosas importantes)
5. **Incontinência** fecal e urinária (investigar e tratar, pois é frequente mas não normal)
6. **Insuficiência familiar e social** (abandono, família sem condições de cuidar, falta de suporte necessário - extremamente significativo)
7. **Incapacidade comunicativa** (déficits sensoriais de audição, visão, problemas de dentição)

Síndrome de Fragilidade

Outra síndrome importante que as provas adoram cobrar. Quando falamos de **síndrome de fragilidade**, estamos nos referindo principalmente àquela síndrome que faz o idoso ter menor autonomia no dia a dia, especialmente na parte de mobilidade, marcha e força reduzida.

Conceito matador: síndrome de fragilidade = idoso frágil da parte óssea, muscular, com menor capacidade de mobilização e menos autonomia para realizar atividades.

Critérios diagnósticos (3 ou mais):

- Perda de peso não intencional
- Exaustão
- Baixa força muscular
- Velocidade de marcha reduzida
- Baixo nível de atividade física

Iatrogenia: Os Medicamentos Problemáticos

Esse é um ponto extremamente importante porque as provas cobram muito. Muitas vezes o paciente idoso usa determinada medicação e está tendo efeito adverso. A questão pergunta: tiro essa medicação ou tiro outra?

Principais fármacos problemáticos em idosos:

Amitriptilina (tricíclico):

- Sedação intensa
 - Delirium
 - Retenção urinária
 - Constipação
 - Hipotensão ortostática
 - Prolongamento do intervalo QT
 - Risco aumentado de quedas e fraturas
- Conclusão:** medicamento que tentamos evitar em idosos.

Benzodiazepínicos:

- Comprometimento cognitivo
- Risco maior de demência
- Delirium
- Sonolência
- Quedas e fraturas
- Dependência

Hipoglicemiantes orais (principalmente sulfonilureias):

- Risco de hipoglicemia grave
 - Confusão mental
 - Tontura
 - Quedas
- Comentário crítico:** o paciente idoso já é mais propenso a hipoglicemia por alterações fisiológicas. Cuidado redobrado.

Anti-hipertensivos (especialmente vasodilatadores):

- Hipotensão ortostática (mais abrupta e súbita)
- Síncope
- Bradicardia

- Retenção urinária
- Confusão mental

Prometazina (anti-histamínico de 1ª geração): Efeitos anticolinérgicos similares à amitriptilina:

- Retenção urinária
- Boca seca
- Sedação
- Risco de quedas
- Visão turva
- Constipação

Anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs):

- Risco de úlcera péptica e perfuração
- Sangramento gastrointestinal
- Piora da insuficiência renal (nefrotóxico)
- Riscos cardiovasculares **Comentário crítico:** o idoso frequentemente já é hipertenso, diabético, tem algum grau de disfunção renal. AINEs não são bons remédios para uso rotineiro nessa população.

Síndrome Demencial: Definição e Conceitos

O que é demência? Definimos demência quando há **dois pontos principais**:

1. **Perda de função cognitiva progressiva e gradual**
2. **Impacto com perda de funcionalidade**

Se o paciente tem comprometimento cognitivo mas consegue fazer tudo que fazia antes, não perdeu autonomia, isso não é demência - chamamos de **comprometimento cognitivo leve (CCL)**.

Principais Domínios Cognitivos

Atenção:

- Sustentada (manter foco)
- Seletiva (escolher no que focar)
- Dividida (realizar atividades consecutivas, como cozinhar e conversar)
- Alternância
- Velocidade de processamento

Memória:

- **Imediata**: repetir palavras logo após ouvi-las
- **Curto prazo/operacional**: coisas do dia a dia
- **Longo prazo**:
 - **Episódica**: conhecimento pessoal (último aniversário, casamento)
 - **Semântica**: conhecimento geral sobre o mundo (Brasília é capital do Brasil)
 - **Procedimental**: como executar tarefas

Funções Executivas: Planejamento e organização de atividades

Linguagem:

- **Fluência verbal:** capacidade de recordar e verbalizar
 - Semântica: relacionada a conteúdo (ex: animais em 1 minuto)
 - Fonêmica: relacionada a letra (ex: palavras com F em 1 minuto)
- Compreensão
- Nomeação
- Repetição
- Leitura
- Escrita

Função Visuoespacial: Desenho, construção, navegação espacial (paciente com prejuízo pode se perder na rua, não encontrar mais locais conhecidos)

Abordagem do Paciente com Queixa Cognitiva

Passo 1: Caracterizar a perda cognitiva

- Aplicar MEEM, MoCA, testes de fluência

Passo 2: Afastar falseadores

- **Delirium** (quadro agudo e flutuante)
- **Medicamentos** (anticolinérgicos, benzodiazepínicos)
- **Depressão** (pseudodemência depressiva - paciente desanimado não se concentra)

Passo 3: Afastar causas reversíveis

- **Hipovitaminose B12**
- **Hipotireoidismo**

Nunca diga que o paciente tem demência sem pedir B12 e TSH!

Exames para Investigação de Demência

Neuroimagem (TC ou RM de crânio): Não é para dar diagnóstico da doença (ex: Alzheimer), mas para **afastar outras causas**:

- Hematoma subdural crônico
- Tumores
- Hidrocefalia
- AVCs

Exames laboratoriais:

- Vitamina B12
- TSH e T4 livre
- Função renal
- Função hepática
- Cálcio
- VDRL (neurosífilis)
- HIV (neuroinfecções oportunistas)

Exemplo de questão (USP-SP 2022): Engenheiro aposentado, 80 anos, esquecimento há 2 anos com piora progressiva. Nos últimos meses, teve dificuldade para lidar com medicamentos que usa há anos. Há um mês, perdeu-se no trajeto entre casas familiares. MEEM: 24/30. Quais exames complementares indicar?

Resposta: vitamina B12, TSH, T4 livre, sorologia para sífilis e HIV, e neuroimagem (tomografia de crânio).

Doença de Alzheimer

Principal causa de demência (mais de 50% dos casos).

Patogênese

Acúmulo de dois componentes tóxicos:

- **Peptídeos beta-amiloide** (extracelular)
- **Proteína tau** (intracelular, dentro do neurônio)

Esse acúmulo gera neurodegeneração, principalmente no **hipocampo**, resultando em atrofia hipocampal marcada e redução da **acetilcolina** (neurotransmissor essencial para funções cognitivas).

Comentário crítico: você NÃO precisa da imagem mostrando atrofia para diagnosticar Alzheimer. O diagnóstico é clínico!

Fatores de Risco

Não adquiridos:

- Idade avançada
- História familiar
- **Mutação do alelo E4 da APOE** (pegadinha de prova - grave isso!)
- **Síndrome de Down** (pegadinha de prova - grave isso!)

Adquiridos:

- Hipertensão
- Dislipidemia
- Doença aterosclerótica
- Sedentarismo

Quadro Clínico

Evolução: crônica e progressiva

- Comprometimento cognitivo leve (CCL) → déficit cognitivo sem perda funcional
- Demência leve → moderada → grave
- Estágios graves: acamamento, dependência total, complicações (trombose, embolia pulmonar, infecções) → óbito

Principal domínio afetado: MEMÓRIA

- **Memória episódica** (fatos pessoais: aniversário, casamento, eventos do dia a dia)
- **Memória semântica** (conhecimento geral)
- **Memória procedimental**

Segundo domínio mais afetado: FUNÇÃO EXECUTIVA Planejamento e organização comprometidos

Outros domínios:

- **Agnosia:** dificuldade em reconhecer objetos/gestos (consegue ver/ouvir, mas não compreende o significado)
- **Apraxia:** dificuldade em executar gestos (tem força motora, sabe o que é, mas não consegue executar o movimento quando solicitado - exemplo: bater palmas)

Quadros avançados:

- Desorientação grave
- Incontinências
- Imobilidade

Diagnóstico (Critérios NIA-AA 2011)

Demência presente (início insidioso, curso progressivo, prejuízo em 2+ domínios cognitivos, prejuízo funcional) + sem critérios para outras demências.

Exame de neuroimagem: pode mostrar atrofia hipocampal, mas não é obrigatório para o diagnóstico.

Tratamento

Primeira linha: Inibidores da acetilcolinesterase (demência leve a moderada)

- Donepezila
- Rivastigmina
- Galantamina

Mecanismo: inibem a acetilcolinesterase (enzima que degrada acetilcolina na fenda sináptica) → mais acetilcolina disponível → mais sinapses → melhora sintomática

Memantina (demência moderada a grave)

- Antagonista do receptor NMDA
- Reduz efeito tóxico excitatório do glutamato
- Efeito adjuvante

Terapias novas: anticorpos monoclonais direcionados à proteína beta-amiloide (ainda não amplamente difundidos)

Demência Vascular

Segunda causa mais comum de demência.

Patogênese

Morte neuronal devido a **fluxo sanguíneo cerebral comprometido**:

- AVC clássico (lesão grande, déficit súbito marcado)
- Microinfartos (às vezes assintomáticos, acumulam-se ao longo dos anos)

Quando Pensar?

Fatores de risco:

- Hipertensão
- Dislipidemia
- Diabetes
- AVC prévio
- Neuroimagem com **doença de pequenos vasos/microinfartos/microbleeds**

Diagnóstico

Evidência de comprometimento cognitivo (principal domínio: **função executiva**) + **prejuízo funcional** + **relação temporal com evento vascular** + **evolução em degraus** (paciente teve AVC → piorou; outro AVC → piorou mais; outro → síndrome demencial marcada) + **evidência de doença cerebrovascular na TC/RM**.

Achados de imagem compatíveis:

- Infarto cortical (área grande, superficial)
- Infarto lacunar (menor que 15mm)
- Hiperintensidade em substância branca
- **Microbleeds** (pontinhos pretos na imagem)

Tratamento

- **Controle de fatores de risco** (hipertensão, diabetes, dislipidemia) - principal medida!

Demência por Corpúsculos de Lewy

Segunda causa de demência degenerativa mais comum.

Patogênese

Acúmulo de **corpúsculos de Lewy** (alfa-sinucleína) nos neurônios → neurodegeneração.

Tríade Clássica (MATADORA DE QUESTÃO!)

1. **Flutuação cognitiva** (variação de atenção e alerta ao longo do dia)
2. **Alucinações visuais bem formadas** (vê pessoas, crianças, animais)
3. **Parkinsonismo espontâneo** (rigidez, bradicinesia, marcha com passos curtos)

PEGADINHA DE PROVA: paciente com demência + alucinação visual → primeira hipótese é LEWY!

Diferença com Parkinson: no Lewy, geralmente primeiro surge o quadro demencial, depois o parkinsonismo. No Parkinson, primeiro a síndrome motora, depois a demência (em fases avançadas).

Tratamento

Primeira linha: Inibidores de acetilcolinesterase, **principalmente rivastigmina.**

CUIDADO: Antipsicóticos nesses pacientes têm risco maior de síndrome neuroléptica maligna. Evitar!

Demência Frontotemporal

Doença neurodegenerativa mais rara que acomete principalmente **lobos frontal e temporal**.

Variantes

- **Comportamental** (mais comum e mais cobrada)
- Linguagem (afasia primária progressiva)
- Função executiva (variante motora)

Quando Pensar?

Variante comportamental:

- **Início antes dos 65 anos** (paciente mais jovem)
- **Mudança comportamental marcante:**
 - Desinibição
 - Agressividade
 - Hipersexualização
 - Comportamento social inadequado
 - Perda de insight
 - Alteração de empatia
- **Memória relativamente preservada no início** (diferente do Alzheimer!)

PEGADINHA DE PROVA: paciente mais jovem com mudança de comportamento bizarra e memória preservada inicialmente → pense em frontotemporal!

Delirium

Quadro agudo e flutuante de alteração da atenção e consciência.

DIFERENÇA CRUCIAL COM DEMÊNCIA:

- Demência: evolução crônica, progressiva, gradual
- Delirium: **início agudo, curso flutuante**, sempre tem **causa subjacente**

Fatores Predisponentes

- Idade avançada
- Demência prévia
- Déficit sensorial (visão/audição)
- Doença grave/fragilidade
- Quadro infeccioso (pneumonia, sepse)

Fatores Precipitantes

- **Polifarmácia**
- **Infecções** (ITU, pneumonia)
- **Distúrbios metabólicos** (hiponatremia, hipoglicemia)
- **Fármacos** (benzodiazepínicos, opioides, anticolinérgicos)
- Desidratação
- Má perfusão
- Cirurgia/anestesia

Diagnóstico (CAM - Confusion Assessment Method)

Obrigatórios:

- Início agudo e curso flutuante
- Déficit de atenção

Mais UM dos seguintes:

- Pensamento desorganizado **OU**

- Alteração do nível de consciência

Tipos Clínicos

- **Hiperativo:** agitação, inquietação, agressividade
- **Hipoativo:** sonolência, lentificação

Manejo

1º passo - CORRIGIR CAUSA BASE!

- Suspende medicamento culpado
- Tratar infecção
- Corrigir distúrbio metabólico
- Reidratar

Tratamento farmacológico:

- Indicado principalmente para **delirium hiperativo** (agitação)
- **Haloperidol** (antipsicótico de 1ª geração)
- **EVITAR benzodiazepínicos** (podem piorar), EXCETO em delirium por abstinência alcoólica

Hidrocefalia de Pressão Normal

TRÍADE CLÁSSICA (MATADORA!):

1. **Marcha magnética** (passos curtos, pés parecem grudados no chão)
2. **Demência** (síndrome cognitiva)
3. **Incontinência urinária**

Fisiopatologia

Hidrocefalia que **NÃO** gera hipertensão intracraniana (por isso "pressão normal"), mas causa sintomas pela dilatação ventricular.

Imagem

Ventrículos dilatados na TC/RM.

Diagnóstico e Tratamento

TAP test (Teste de Punção Lombar):

- Realizar punção lombar
- Retirar quantidade de líquido
- Avaliar melhora dos sintomas (cognição, marcha)
- Melhora após punção confirma diagnóstico

Tratamento definitivo: Derivação ventrículo-peritoneal (cateter conecta ventrículo ao peritônio, drenando o líquido continuamente)

Resumo dos Gatilhos

ALZHEIMER:

- Domínio: memória episódica
- Imagem: atrofia hipocampal
- Gatilho: degeneração gradual, memória prejudicada desde o início

VASCULAR:

- Domínio: função executiva
- Imagem: hiperintensidade substância branca, microbleeds, microinfartos
- Gatilho: **curso em degraus**, fatores de risco vascular

CORPÚSCULOS DE LEWY:

- Domínio: flutuação + alucinação + parkinsonismo
- Gatilho: **TRÍADE clássica + flutuação**
- Imagem: PET com hipocaptação sem amiloide, mas geralmente diagnóstico clínico

FRONTOTEMPORAL:

- Domínio: comportamento
- Gatilho: início <65 anos, **mudança comportamental bizarra**, memória preservada inicialmente
- Imagem: atrofia frontal/temporal

HIDROCEFALIA PRESSÃO NORMAL:

- Domínio: marcha + demência + incontinência
- Gatilho: **tríade de Hakim-Adams**, ventrículos dilatados
- Tratamento: TAP test (melhora pós-punção lombar), derivação definitiva